

BELLO - ANTIOQUIA, 16/4/2026

PACIENTE: Agudelo Londoño, Angie Melisa

IDENTIFICACIÓN: 1018350574

EDAD: 29A 4M

ENTIDAD:

Fecha del Estudio 15/4/2026

Fecha Informe: 15/4/2026

RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA CERVICAL CONTRASTADA, RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA DORSAL CONTRASTADA

INDICACIÓN:

“Paciente con dorsalgia derecha interescapular irradiado a miembro superior derecho”

TÉCNICA:

Con magneto superconductor que opera a 1.5 tesla se realizan en la columna cervical, dorsal y lumbar secuencias de pulso TSE T1 axial sagital y TSE T2 axial, coronal y sagital, STIR sagital y GRE T2 axial en la columna cervical y secuencias contrastadas con gadolinio T1 con y sin supresión grasa.

COLUMNA CERVICAL:

HALLAZGOS:

Se conserva la lordosis cervical fisiológica.

La altura, morfología y señal de intensidad de los cuerpos vertebrales cervicales es normal.

Discos intervertebrales con cambios por osteocondrosis inicial.

El canal central tiene amplitud normal en los todos segmentos evaluados.

No hay signos de luxación o subluxación.

La señal de intensidad de la médula espinal es normal.

Las arterias vertebrales conservan su vacío de señal por flujo.

Posterior a la administración de medio de contraste no se observan realces patológicos.

En lo parcialmente incluido en la base del cráneo se observa aparente lesión quística de ubicación central en la hipófisis de 4 mm de carácter inespecífico correlacionar con estudio dirigido.

COLUMNA DORSAL:

HALLAZGOS:

Se conserva la cifosis dorsal fisiológica.

La altura, morfología y señal de intensidad de los cuerpos vertebrales dorsales es normal.

Los discos intervertebrales preservan su altura y señal de intensidad normales.

El canal central tiene amplitud normal en los todos segmentos evaluados.

No hay signos de luxación o subluxación.

Articulaciones facetarias y costovertebrales dentro de los límites normales.

La señal de intensidad de la médula espinal es normal.

Posterior a la administración de medio de contraste no se observan realces patológicos.

Tejidos blandos para y prevertebrales y lo incluido del parénquima pulmonar sin lesiones.

CONCLUSIÓN:

Cambio por osteocondrosis inicial en la columna cervical.

En los diferentes espacios intervertebrales cervicales y dorsales evaluados no se observa herniación discal, estenosis de canal central, estenosis foraminal, así como tampoco compresión del cordón medular o radicular.

No hay signos de mielopatía.

En lo parcialmente incluido en la base del cráneo se observa aparente lesión quística de ubicación central en la hipófisis de 4 mm de carácter inespecífico correlacionar con estudio dirigido.

Informe Firmado Electrónicamente por:

Rafael Enrique Llamas Otero

68-1739-12

Neurorradiólogo